

ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO



**Perforativo, Isquémico, Hemorrágico y Complicaciones
(Guía Visual de Alto Rendimiento)**

Proyecto Académico Exclusivo

1. PERFORATIVO

Ruptura de víscera hueca (Úlcera, Apéndice, Divertículo, Vesícula).

Clínica: Signos de irritación peritoneal, abdomen en tabla.



2. ISQUÉMICO

Compromiso del flujo esplácnico (Embolia/Trombosis).

Clínica: Dolor desproporcionado a los hallazgos físicos.



3. HEMORRÁGICO

Sangrado libre intraperitoneal (Trauma, Embarazo ectópico).

Clínica: Shock hipovolémico silencioso.



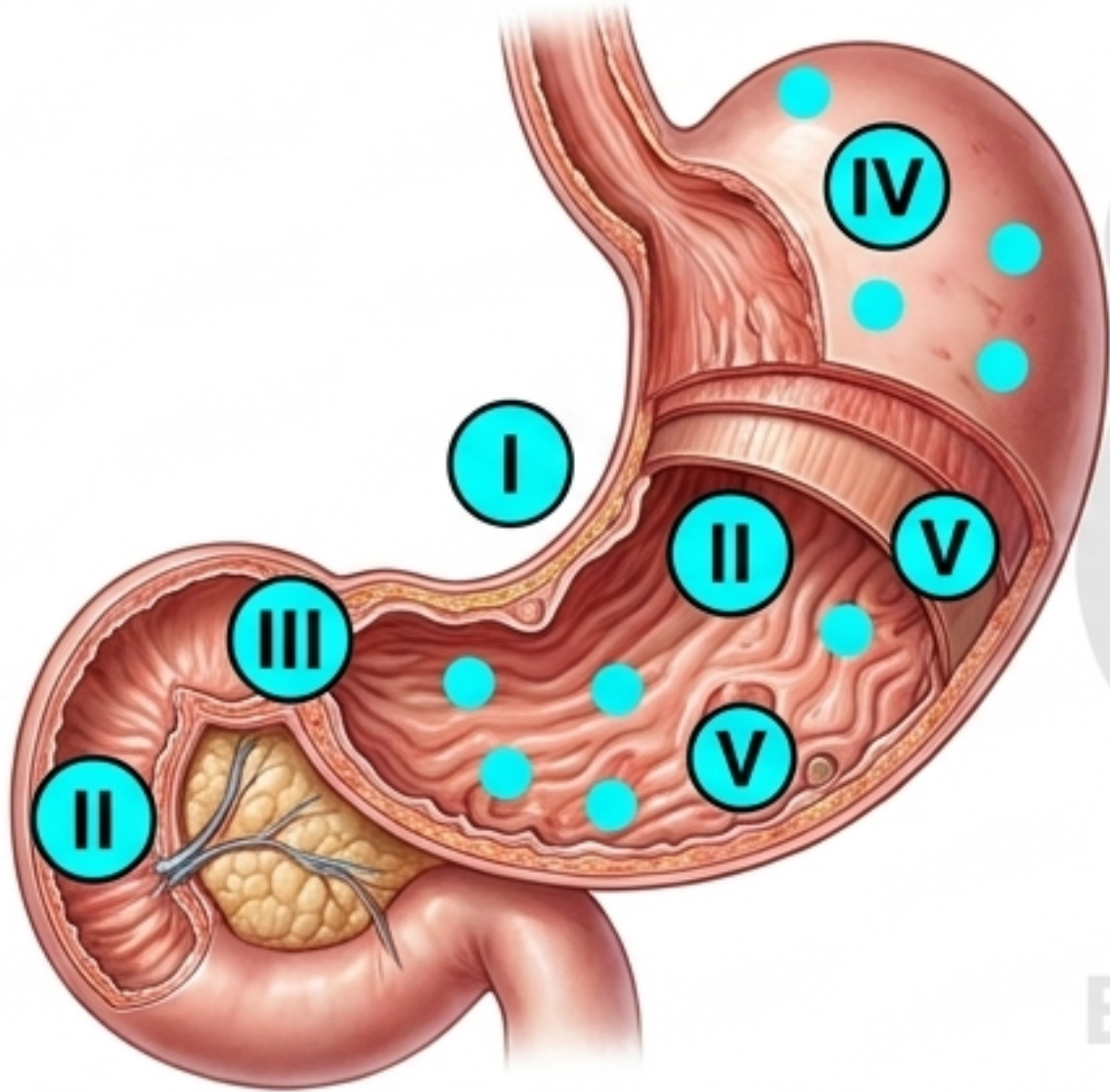
4. COMPLICACIONES

Infecciosas (Peritonitis, Abscesos) y Mecánicas/Vasculares (Dehiscencia, SCA).



ABDOMEN PERFORATIVO I: Enfermedad Úlcero-Péptica

Clasificación de Johnson

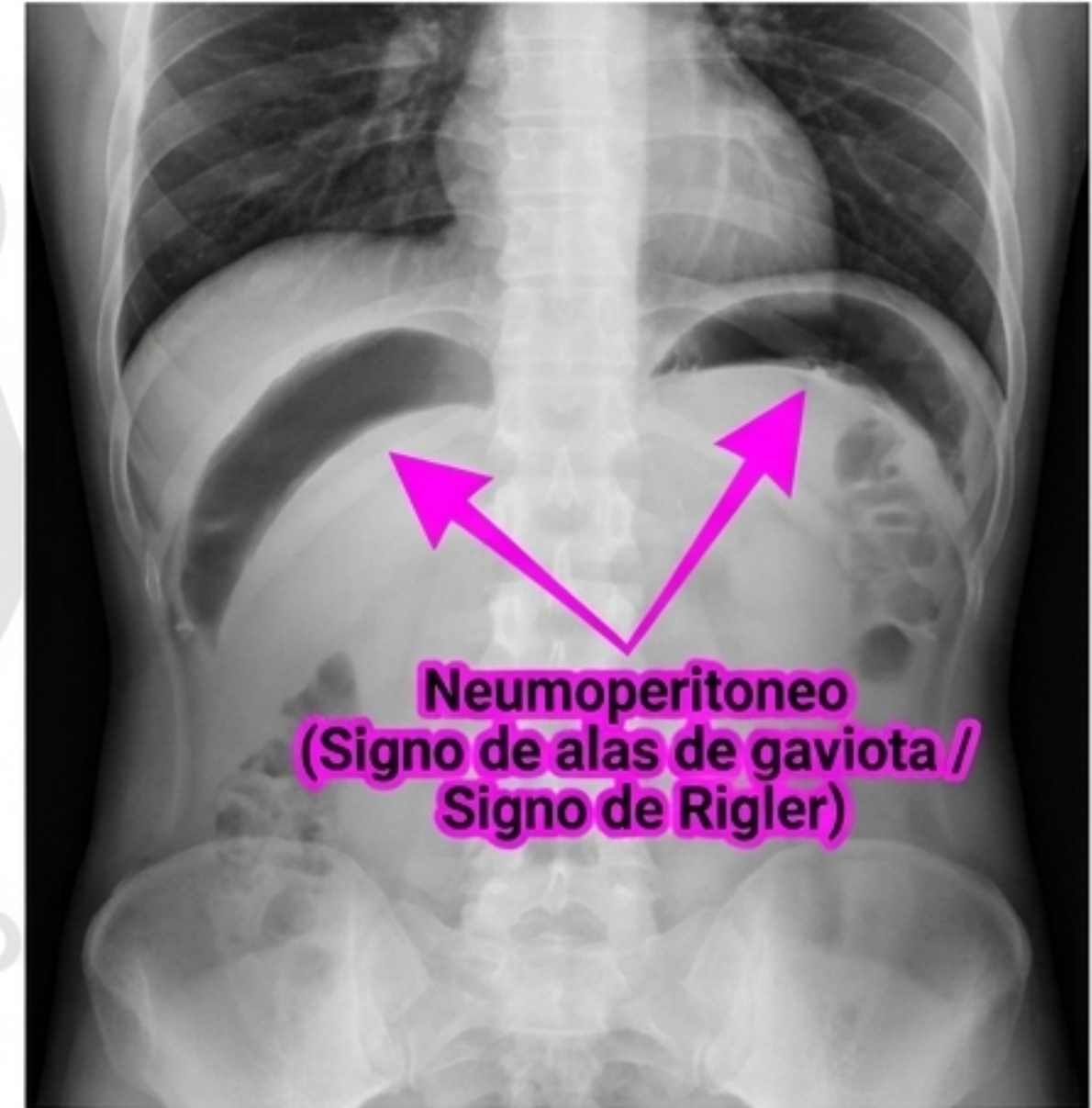


I: Curvatura menor.
II: Gástrica + Duodenal
(hipersecreción).
III: Prepilórica.

III: Prepilórica.
IV: Proximal/Fondo.
V: Inducida por AINEs
(múltiples).

Nota Etiológica: AINEs (Diclofenaco, Naproxeno) y H. pylori.

Presentación Clínica



Dolor epigástrico súbito, abdomen en tabla (66%).
Signo de Jobert: Desaparición de la matidez hepática.

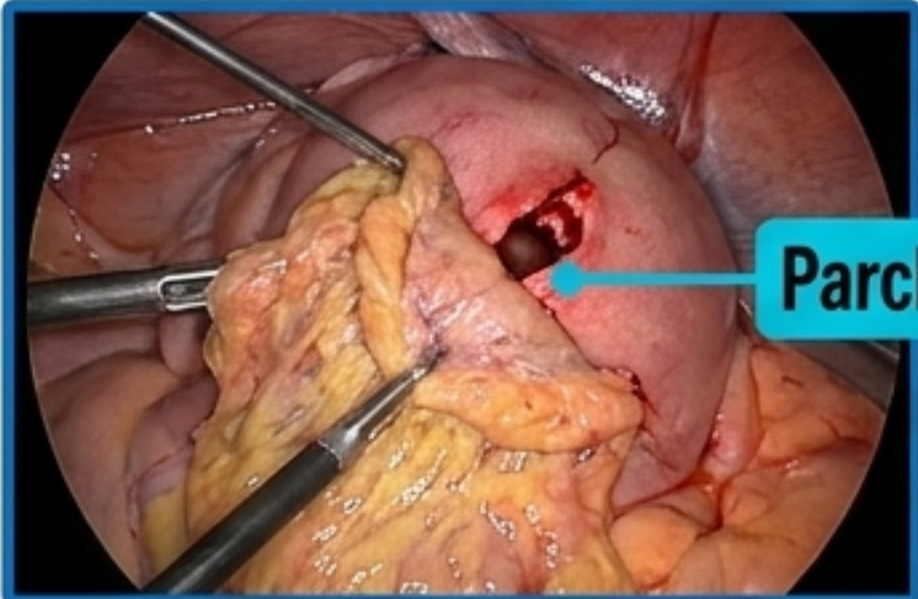
Manejo de la Úlcera Perforada: Reanimación + Sonda Nasogástrica + Analgesia/IBP

Manejo Quirúrgico (Estándar)

Cierre Primario: Sutura directa.

Reparación de Cellan-Jones: Sutura cubierta con epiplón pediculado.

Parche de Graham: Tapón de epiplón libre.



Parche de Graham

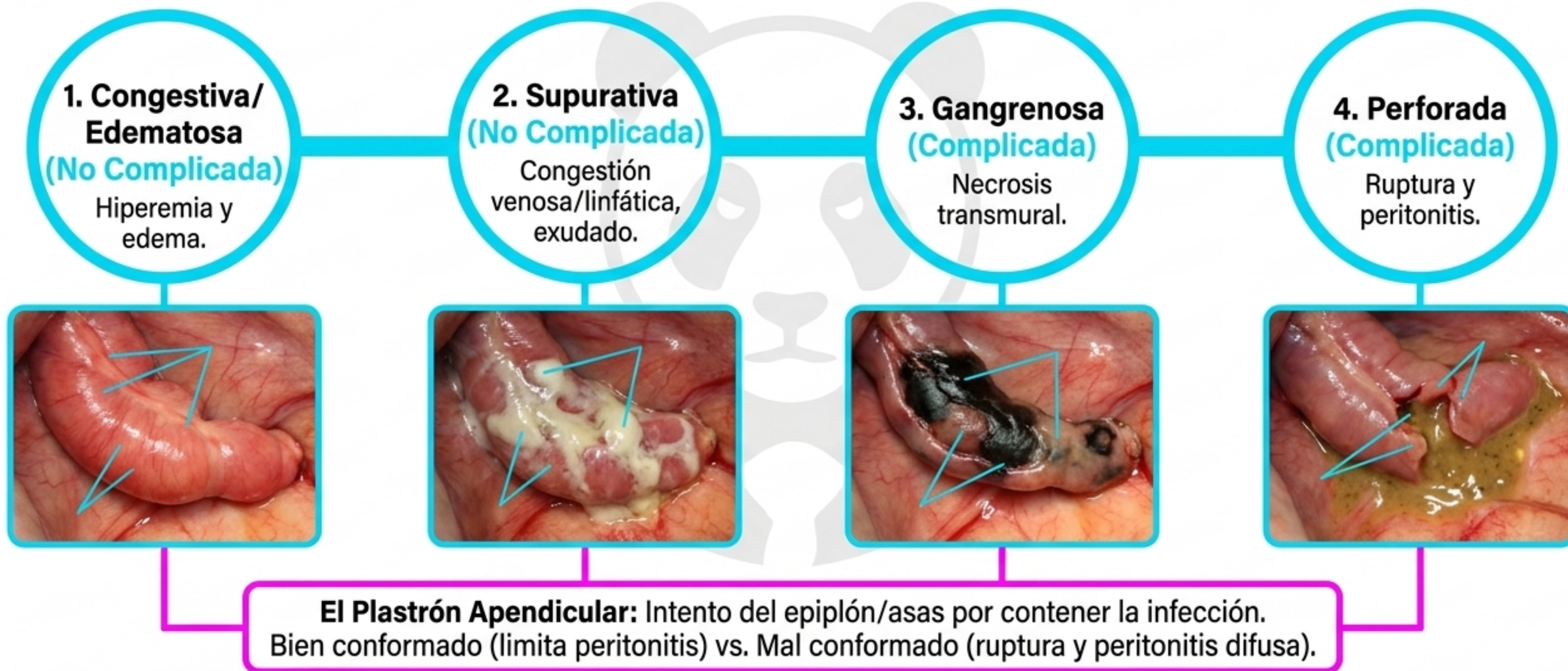
Manejo Conservador (Método de Taylor)

Criterios: Riesgo quirúrgico altísimo + perforación clínicamente sellada (40-80% se sellan).

Acción: Aspiración, goteo endovenoso, antibióticos, reevaluación continua.

ABDOMEN PERFORATIVO II: Fases de la Apendicitis

Etiología: Hiperplasia linfoide en niños vs. Fecalito en adultos



ABDOMEN PERFORATIVO III: Diverticulitis y Colectitis

Diverticulitis Perforada (Clasificación de Hinchey)

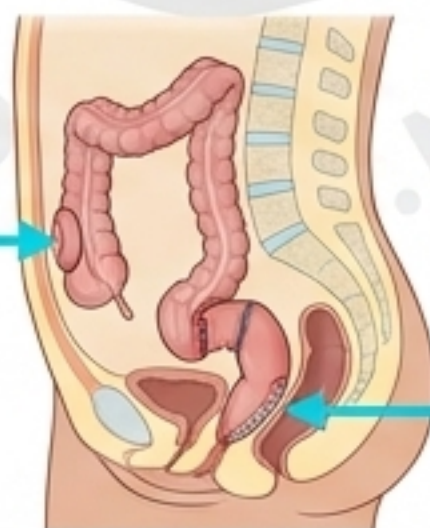
- **I:** Absceso pericólico/mesentérico (Manejo conservador/drenaje).
- **II:** Absceso pélvico/distante (Drenaje percutáneo).
- **III:** Peritonitis purulenta generalizada.
- **IV:** Peritonitis fecal generalizada.



Absceso Pericólico

Hinchey III y IV requieren **Procedimiento de Hartmann** (Resección + Colostomía terminal + Muñón rectal).

Colostomía Terminal



Muñón Rectal

Colecistitis Perforada (Clasificación de Niemeier)

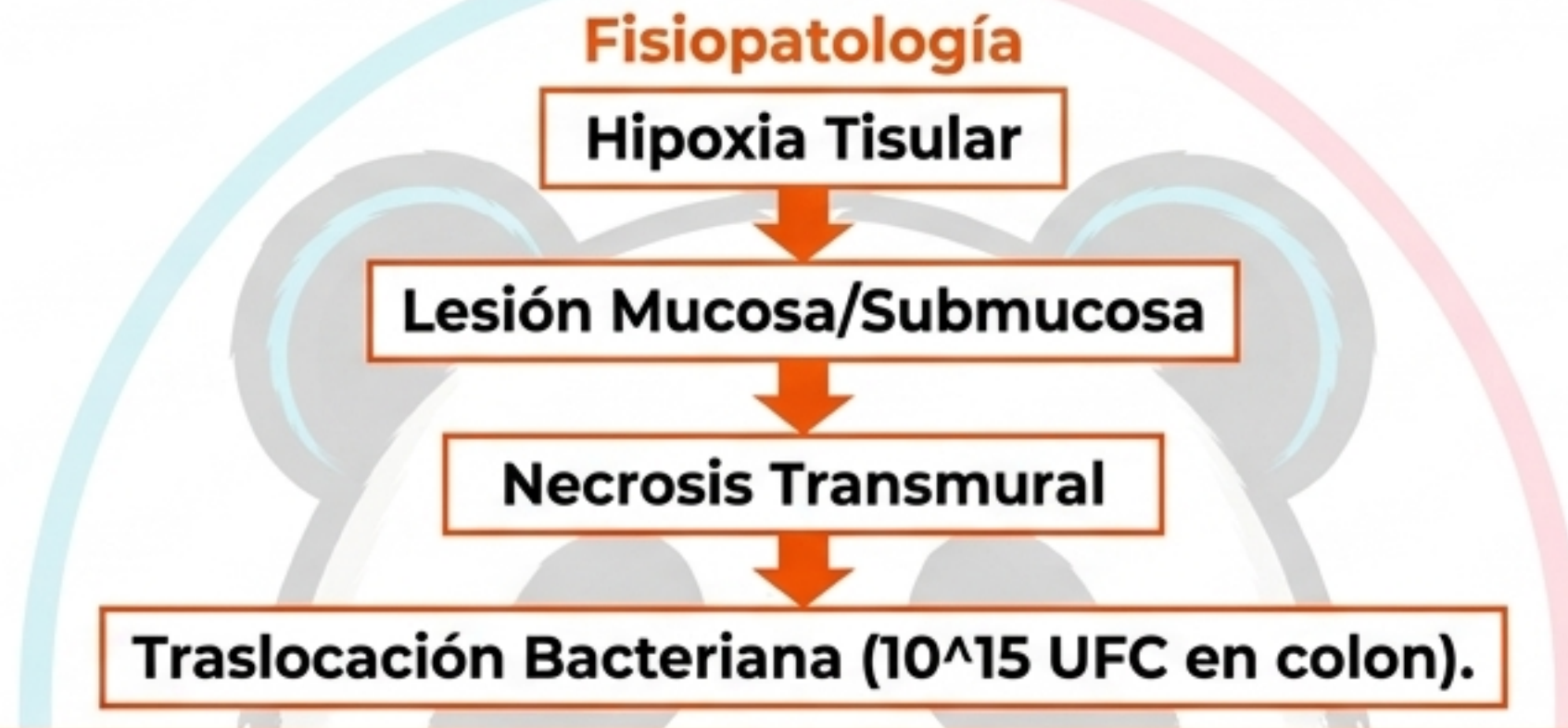
- **I:** Perforación libre con peritonitis biliar -> Colectectomía de urgencia.
- **II:** Perforación contenida (absceso perivesicular) -> Drenaje percutáneo inicial.
- **III:** Perforación crónica con fístula -> Cirugía compleja de resección.

Perforación Contenida (Absceso Perivesicular)



Nota: Suele perforarse en el fundus (menor vascularización, mayor tensión).

Abdomen Isquémico: La Cascada Silenciosa



Clínica y Laboratorio:

Signo Cardinal: Dolor desproporcionado a los hallazgos físicos.

Laboratorio: Leucocitosis con desviación izquierda, Acidosis metabólica (Anión Gap elevado), Lactato sérico alto, Dímero D positivo. Elevación de Amilasa/CPK.



Signo de las Huellas Dactilares (Thumbprinting)



Neumatosis Intestinal

BADBEAR.MED



BADBEAR.MED: Facebook, Instagram, YouTube, Rutube, OnlyFans, Telegram, Gemini Notebook

El Algoritmo de Salvataje Isquémico: Las 4 R

1

Reanimación

Corrección hídrica rápida, control de acidosis y antibióticos de amplio espectro.

2

Rápido Diagnóstico

AngioTAC de urgencia (evaluar arteria mesentérica superior).

3

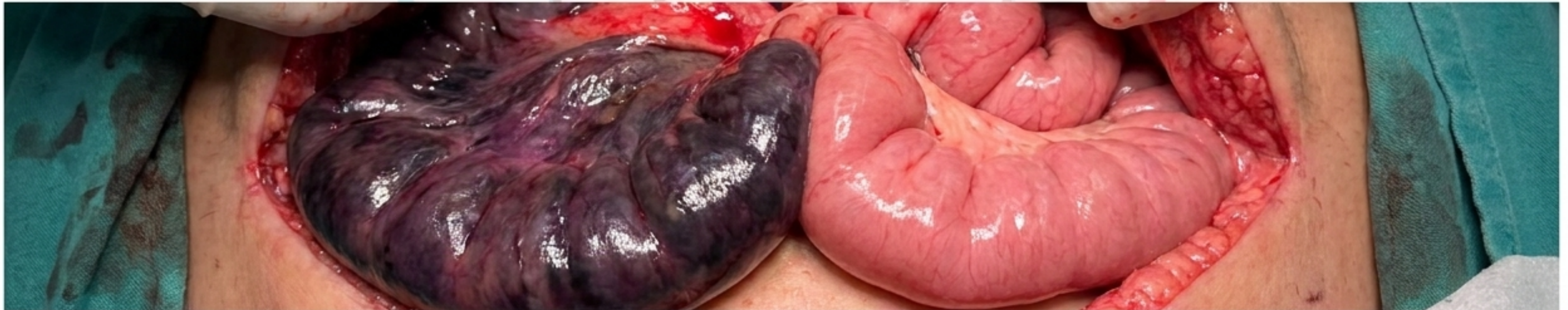
Revascularización

Si el tejido es viable:
Embolectomía o Bypass.
Si hay necrosis:
Resección del intestino inviable.

4

Reevaluación (Second Look)

Laparotomía programada a las 48-72 horas para reevaluar la viabilidad de los bordes intestinales antes de la anastomosis definitiva.



Abdomen Hemorrágico: Clínica y Diagnóstico

El Cuadro Clínico

Mecanismos: Ruptura de víscera sólida (Trauma), Embarazo Ectópico, Malformaciones.

Clínica: Shock hipovolémico silencioso (taquicardia, palidez, diaforesis). Dolor abdominal difuso de inicio súbito.



Signo de Cullen
(Periumbilical)



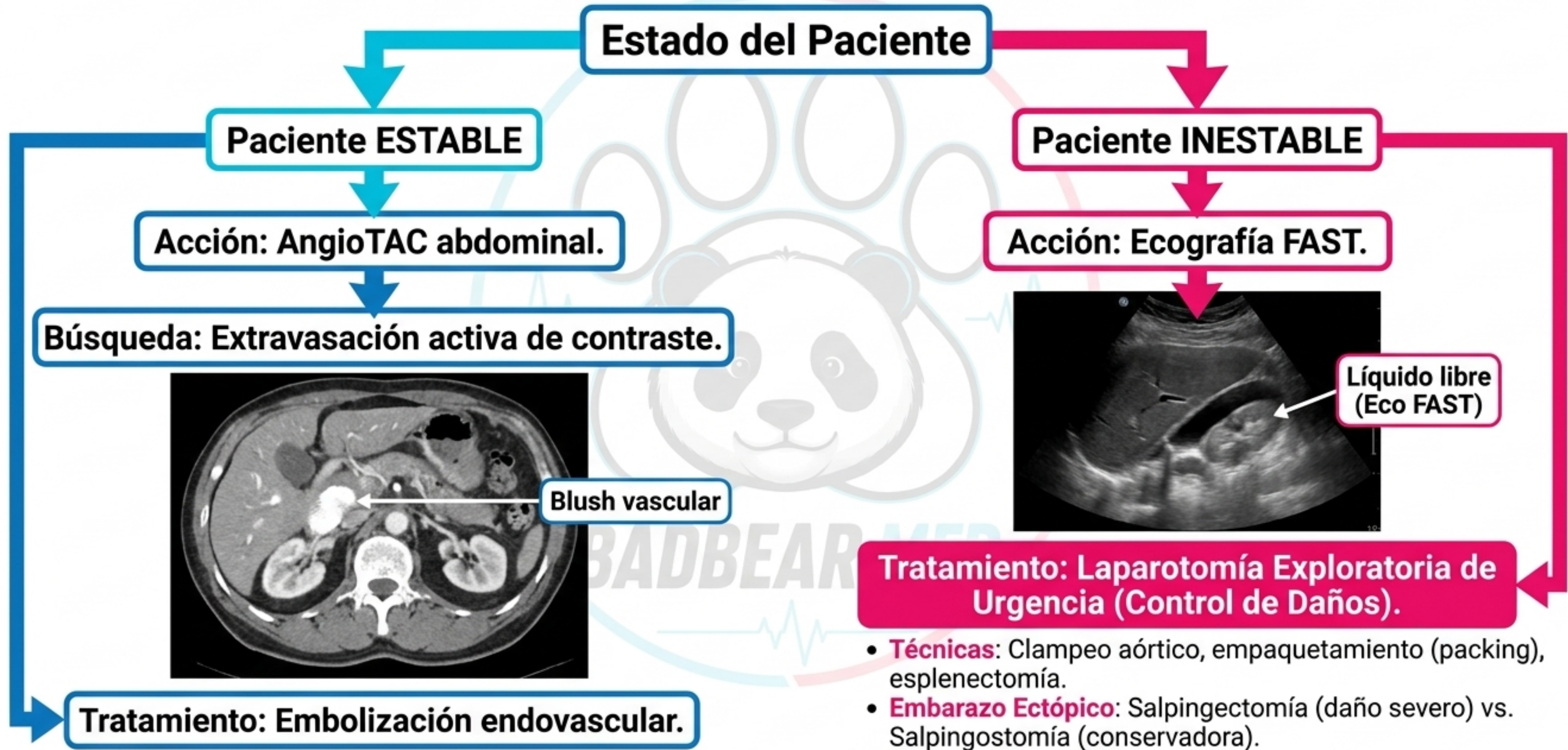
Signo de Grey Turner
(Flancos)

El Laboratorio y Triage

Regla de Oro: Dosaje obligatorio de β -hCG en toda mujer en edad fértil.

- **Dato:** Hemoglobina/Hematocrito iniciales pueden ser falsamente normales antes de la hemodilución.
- **Marcador pronóstico:** Lactato elevado (hipoperfusión).

Abdomen Hemorrágico: Algoritmo de Acción



Complicaciones Infecciosas: Peritonitis y Abscesos

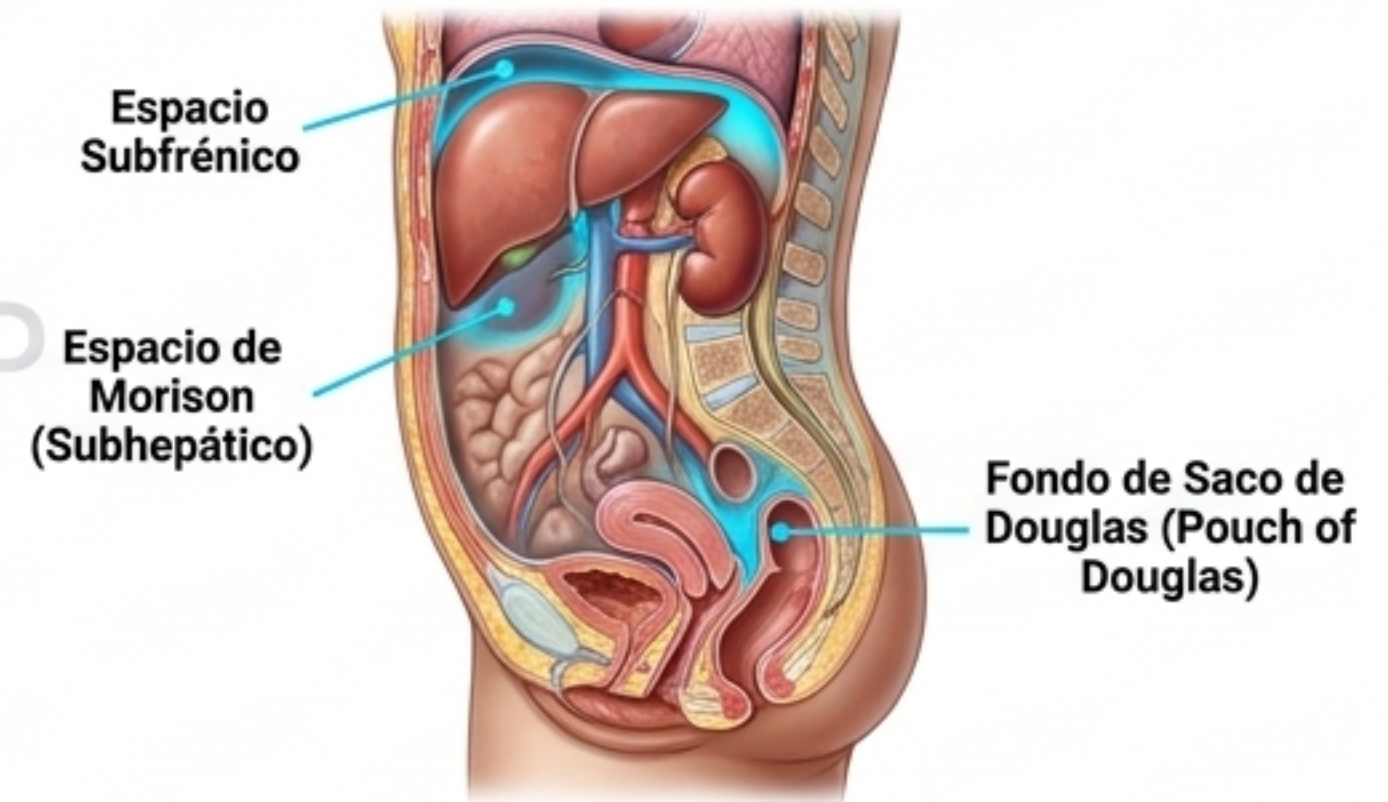
Característica	Peritonitis Secundaria	Peritonitis Terciaria
Causa	Pérdida de integridad del TGI (perforación, isquemia, dehiscencia).	Infección recurrente >48h post-tratamiento de peritonitis secundaria.
Huésped	Inmunocompetente.	Inmunosuprimido / Paciente UCI.
Microbiología	Flora endógena (E. coli, B. fragilis).	Oportunistas y Multirresistentes (Enterococcus faecium, Pseudomonas, Acinetobacter, Candida).

Abscesos Intraabdominales

Fisiología: Mecanismo de contención (fibrina/tejido de granulación).

Localizaciones clásicas: Subfrénico, Subhepático, Espacio de Douglas.

Clínica: Fiebre en picos, íleo adinámico, leucocitosis persistente.



BADBEAR.MED: Facebook, Instagram, YouTube, Rutube, OnlyFans, Telegram, TikTok

Complicaciones Mecánicas: Dehiscencia y Evisceración

Dehiscencia de Anastomosis

Falla de cicatrización/isquemia/tensión.

Signo clave: Drenaje de contenido fecaloide.

Grado A: Asintomática, sin repercusión.

Grado B: Colección localizada, estable (fiebre/íleo). Líquido purulento.

Grado C: Fuga severa, peritonitis difusa, shock, abdomen en tabla.

Evisceración

Salida de vísceras por herida/puntos rotos.



Signo Patognomónico: Exudado color salmón ("Agua de lavado de carne").

Tipo 1 (Cubierta):

Piel intacta, ruptura fascial.

Manejo: Faja, cirugía diferida.

Tipo 2 (Expuesta): Piel y fascia abiertas, vísceras expuestas.

Manejo: Cubierta estéril húmeda + Cirugía urgente.



Hipertensión Intraabdominal y Síndrome Compartimental (SCA)

$$PPA = PAM - PIA$$

(Presión de Perfusión Abdominal = Presión Arterial Media - Presión Intraabdominal).

Alerta: PPA < 60 mmHg = Isquemia Visceral Severa.

Grados de Hipertensión (PIA normal: 0-5 mmHg)

II: 16-20
(Viantante: II: Cyan)

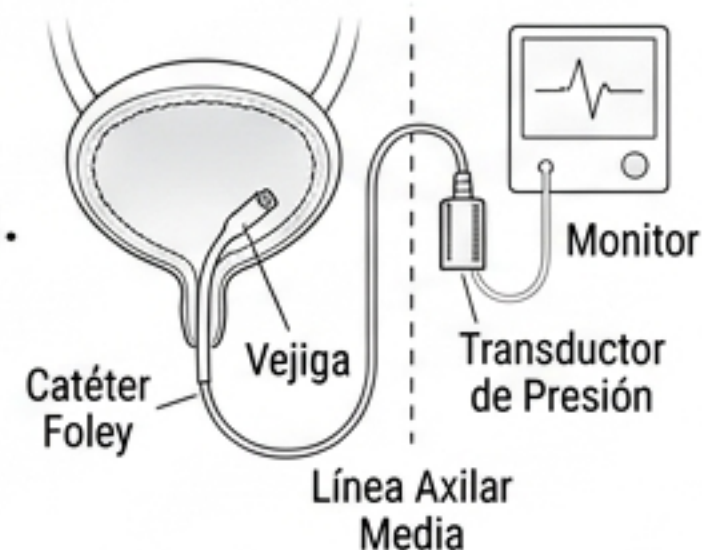
I: 12-15
(Zoning: Cyan)



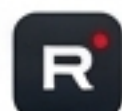
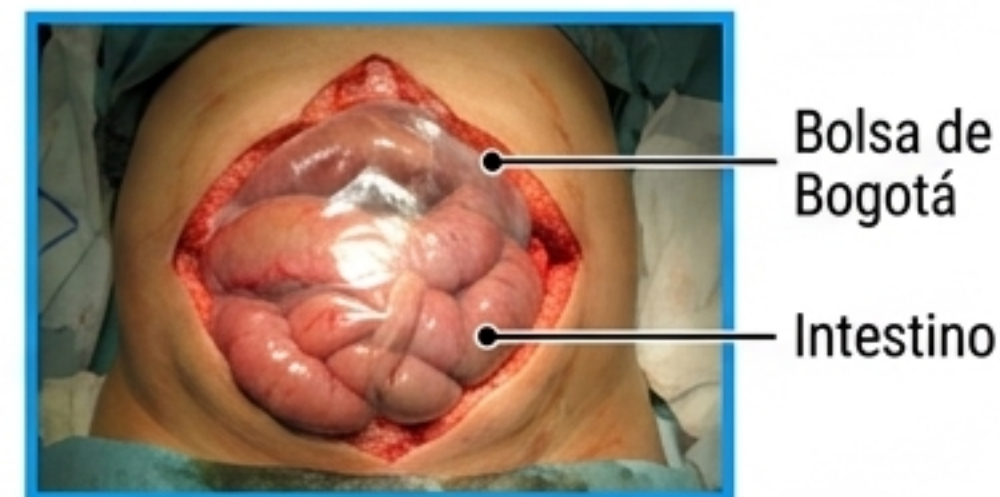
III: 21-25
(Monior omíHg stear)

IV: >25 mmHg
(Alerta: onar IV magenta)

Medición Transvesical: Instilación máxima de 25 ml de solución salina (evitar tono falso del detrusor). Calibración en cero en línea axilar media. Decúbito supino estricto, al final de la espiración.



Tratamiento: Laparotomía descompresiva (PIA > 20 + falla de órgano).
Uso de **Bolsa de Bogotá** o **Sistema VAC** para cierre temporal.



BADBEAR.MED: Facebook, Instagram, YouTube, Rutube, OnlyFans, Telegram

Gemini Notebook

La Matriz Maestra de Antibióticos Intraabdominales

Pilar 1: Control de Fuente (Drenaje/Resección) | Pilar 2: Terapia Antimicrobiana

Comunidad (Leve/Moderada)

Esquema: Ceftriaxona (1-2g/24h) + Metronidazol (500mg/8h).

Cobertura: Enterobacterias y anaerobios (*B. fragilis*).

Comunidad (Grave/Shock Séptico)

Esquema: Piperacilina-Tazobactam (4.5g/6h) o Meropenem (1g/8h) o Cefepime + Metronidazol.

Cobertura: Amplio espectro incluyendo Pseudomonas.

Nosocomial / Terciaria / Multirresistente

Esquema Base: Meropenem o Ceftazidima-Avibactam.

Cobertura MRSA: + Vancomicina o Linezolid.

Cobertura Fúngica: + Fluconazol o Caspofungina (indicado tras fracaso terapéutico prolongado).

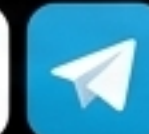
Nota: Ciclos cortos de 4-7 días si hay buen control del foco. Infección no complicada operada en <24h: Profilaxis única, no postoperatoria.



Reglas de Oro del BADBEAR:

- 1. El neumoperitoneo es quirúrgico hasta demostrar lo contrario.
- 2. Dolor desproporcionado = Isquemia. El tiempo es intestino.
- 3. Mujer en edad fértil con shock silencioso = Ectópico roto (β -hCG vital).
- 4. El control de la fuente es superior a cualquier antibiótico.

Domina la cirugía. Estudia con la máxima eficiencia.

Síguenos y únete al proyecto BADBEAR.MED en:     
  **Facebook, Instagram, | YouTube, Rutube, OnlyFans, Telegram, TikTok**